SDD 307 Sujet n°2

Spécialité : Génétique médicale

Date : 23/02/2025
Auteur : PIOTROWSKI Johanne, interne Génétique Médicale
Relecteur(s) : Dr DURAND Benjamin, Généticien Clinicien IGMA Strasbourg,
Lionel Heiser, interne de Génétique Médicale, HCL, et responsable spécialité Génétique

Domaine d'apprentissage principal	Annonce/information au patient
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie Education/prévention
Item(s) en lien avec la station	Item 45 - Spécificités des maladies génétiques (voir item 9)
Situation(s) de départ en lien avec la station	307 - Dépistage prénatal de la trisomie 21 327 - Annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille
Matériel nécessaire à la station	Résultats d'échographie Résultats génétiques
Contexte de la station	Vous êtes interne en génétique et recevez pour la 2ème fois Mme I, enceinte à 25 SA. Il existait un risque combiné de la trisomie 21 (T21) au premier trimestre à 1/300 et le Diagnostic Prénatal Non Invasif (DPNI) était positif pour une T21. Vous l'aviez rencontrée pour lui expliquer l'amniocentèse et avez reçu le résultat il y a peu.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne en génétique et recevez pour la 2ème fois Mme I, une patiente enceinte à 25 SA. Il existait un risque combiné de la trisomie 21 (T21) au premier trimestre de 1/300 et le Dépistage Prénatal Non Invasif (DPNI) était positif pour une T21. Vous l'aviez rencontrée pour lui expliquer l'amniocentèse et avez reçu le résultat il y a peu.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Repérer les signes échographiques en faveur d'une T21 chez le fœtus de Mme I
- Annoncer le résultat de l'amniocentèse à Mme I
- Répondre à ses quatre premières questions

Vous ne devez pas :

- Réaliser de prescription
- Réaliser d'examen clinique

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station **avec** patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
Partie I : recontextualisation de la consultation			
Rappelle les signes échographiques de T21 : **Hypoplasie des os propres du nez**		1 pt	☐
Rappelle les signes échographiques de T21 : **Retard de croissance intra-utérin ou os longs courts**		1 pt	☐
Partie II : annonce des résultats de l'amniocentèse			
Prononce les mots « trisomie 21 »		1 pt	☐
Explique qu'il y a trois chromosomes 21 au lieu de 2		1 pt	☐
Demande si la patiente a des questions		1 pt	☐
Partie III : réponse aux questions de la patiente			
Q1	Dit que le seul facteur de risque est l'âge maternel	1 pt	☐
	Explique brièvement la non-disjonction des chromosomes pendant la méïose = division cellulaire	1 pt	☐
Q2	Précise que la T21 est associée à un **retard psychomoteur**	1 pt	☐
	Précise qu'il y a un **déficit intellectuel** plus ou moins sévère	1 pt	☐
	Précise que cette maladie est souvent associée à une cardiopathie (CAV, CIV, CIA)	1 pt	☐
	Rapporte la présence d'autres complications : au moins 2 parmi - déficit immunitaire / infections, - dysthyroïdie, - morphologie caractéristique (sans plus de précision), - surdité, - épilepsie, - SAOS, - cataracte, - leucémie	1 pt	☐
Q3	Précise qu'il y aura un suivi rapproché de la grossesse et de l'enfant	1 pt	☐
	Rapporte qu'il y aura une prise en charge sociale liée au handicap : doit citer « **aides financières** » OU « **MDPH** » OU « **aménagement à l'école** »	1 pt	☐
	Expliquer qu'il est possible de demander une IMG (interruption médicale de grossesse) sur acceptation du CPDPN, en RCP / réunion pluridisciplinaire	1 pt	☐

Q4	Précise que le risque de T21 pour une prochaine grossesse est faible, un peu plus élevé que la population générale car libre et homogène (*non évalué : 1%)*	1 pt	☐
	Possibilité de diagnostic prénatal (*non évalué : DPNI ou invasif*) pour une prochaine grossesse	1 pt	☐

Communications et attitudes

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

TOTAL	**/19**

Éléments de rétroaction :

Expliquer à la patiente les possibilités de prise en charge diagnostique selon le résultat du dépistage

>1/50 : caryotype fœtal
Entre 1/51-1/1000 : DPNI
<1/1000 : arrêt du dépistage

En cas de DPNI T21 positif
→ on confirme par FISH (délai 48h) et caryotype foetal (délai 2 semaines)

Principales manifestations cliniques T21

CAV, CIV, CIA (souffle)

Atrésie anale
Sténose duodénale
Maladie de Hirschprung
Maladie coeliaque, DT1

Retard psychomoteur
Déficience intellectuelle QI 45-70
Déficit attentionnel, impulsivité, intolérance à la frustration
TSA 5-10%
West (spasmes infantiles) 10%
Alzheimer précoce (50 ans)

Hypoacousie/ Surdité 50%
Infections ORL à répétitions
Cataracte congénitale (1%)
50 % SAOS
Troubles de l'oralité
RGO, hernie hiatale

Hypotonie ++ néonatale
Retard de croissance -2 DS
Pieds plats avec valgus fréquent
Hyperlaxité, instabilité C1/C2

Dysmorphie :
Microcéphalie, visage rond plat ; fentes palpébrales en haut et en dehors ; oreilles petites et rondes ; nuque plate ; hyperlaxité articulaire et cutanée ; brachymésophalangie des 5 doigts : clinodactylie ; PPTU (2/3 des cas) ; espacement accru entre le premier et le deuxième orteil avec une plante des pieds plissée

Dépister :
- **Hypothyroïdie** : TSH + T4L 1x/an
- **NFS / 2 ans** thrombopénie, anémie, LAM
- Surdité, anomalies visuelles
- Maladie coeliaque
- LAL et LAM : hépato-splénomégalie
- SAOS
- Douleur
- Altérations de l'humeur
- K Testicule

Prise en charge :
- Kiné
- Psychomot
- Orthophonie
- CAMSP (0-6ans)
- Psychologique
- Associations de patients

Conseil génétique :
Récurrence
- T21 libre et homogène : 1%
- Translocation : si un parent présente un réarrangement équilibré
  - Transloc 14;21 mère : 15%
  - Transloc 14;21 père : 5%

Transmission à la descendance : 1/3
- risque augmente avec l'âge de la patiente

LISA : Item 9 spécificité des maladies génétiques
PNDS Trisomie 21 (has-santé.fr)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds-« je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :

Vous êtes interne en génétique et recevez pour la 2ème fois Mme I, cette dernière est enceinte à 25 SA. Il existait un risque combiné de la trisomie 21 (T21) au premier trimestre à 1/300, le diagnostic Prénatal Non Invasif (DPNI) était positif pour une T21. Vous l'aviez rencontrée pour lui expliquer l'amniocentèse et avez reçu le résultat il y a peu.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Recontextualiser rapidement la consultation en expliquant les signes échographiques en faveur d'une T21.
- Annoncer le résultat de l'amniocentèse à Mme I.
- Répondre à ses quatre premières questions.

Plan de la station ECOS :

Patient simulé placé en face du candidat.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

« Vous m'avez dit que vous aviez les résultats alors je suis venue au premier créneau de consultation disponible. »

Identité du patient :

Mme I, 35 ans.

Mode de vie :

AESH. A déjà 2 enfants avec M. I (35 ans) qui sont en bonne santé

Comportement global :

Laisser un temps de silence après l'annonce, ne pas trop réagir, hocher la tête sans parler.

Questions :

Après 4 min, si l'étudiant ne demande pas « avez-vous des questions », poser la première question.
Enoncer les questions à 30 sec - 1 min d'intervalle et ce, peu importe la réponse, afin que l'étudiant puisse donner une réponse à chacune.
Question 1 : « Pourquoi c'est arrivé ? Est-ce qu'il y a des choses qui favorisent ? »
Question 2 : « Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? »
Question 3 : « Est-ce que je peux demander une interruption de grossesse ? Et comment ça va se passer si je souhaite la poursuivre ?»
Question 4 : « Et pourquoi nos autres enfants vont bien ? Et si on en veut un autre, est-ce qu'il aura la même pathologie ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

L'étudiant commence par lire les documents complémentaires disponibles et les commenter à l'examinateur.
Le patient simulé se tient soit à l'arrière de la pièce soit à l'extérieur/dans une autre pièce (cela doit être indiqué).
Puis l'étudiant fait entrer le patient, qui se place en face de lui.

Matériel nécessaire à la station :

- *Grille d'évaluation pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Documents complémentaires (échographie + résultat caryotype).*

Documents annexes

Madame I

Echographie fœtale spécialisée 23 SA

Indication : recherche de malformations, DPNI positif T21

Résultats :
Fœtus de sexe masculin
Liquide en quantité normale. Mouvements actifs fœtaux.
Longueur du fémur : 40 mm (- 2.5 DS). Poids fœtal estimé au 3e percentile.
Pas d'anomalie des mains ni des pieds.
Hypoplasie des os propres du nez.
Pas d'anomalie des anses intestinales. Reins d'aspect échographique normal.
Pas d'anomalie décelée au niveau cérébral.
Pas d'anomalie décelée au niveau cardiaque.

Madame I

Caryotype fœtal réalisé sur amniocentèse à 24 SA

Indication : recherche de trisomie 21, DPNI positif T21

Mitoses observées : 20

Mitoses classées : 6

Résolution : ≥ 550

Compte rendu : **47, XY, + 21**
Caryotype d'un fœtus masculin porteur d'une trisomie 21 libre et homogène sur les 20 mitoses observées en cytogénétique conventionnelle. Une consultation de génétique est à prévoir.